



Jangan Digunakan
Kembali

Petunjuk Penggunaan
KIZASHI
(KANEKA KIZASHI Cutting Balloon Catheter)

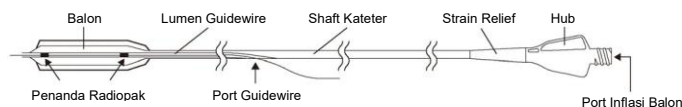


Disterilkan Menggunakan
Etilen Oksida

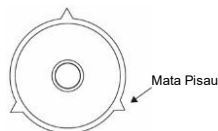
[Deskripsi Perangkat]

1. Bentuk dan Struktur

(1) Kateter Balon



(2) Tampilan Penampang Balon



(3) Jarum Pembilas



2. Bahan Bagian Utama

(1) Shaft Kateter

Nylon-based Resin, Polyethylene, Stainless Steel, Polytetrafluoroethylene, Urethane Adhesive, Hydrophilic Coating

(2) Balon

Nylon-based Resin

(3) Jarum Pembilas

Polypropylene, Stainless Steel

3. Tekanan Nominal dan Tekanan Burst Terukur

Tekanan Nominal	Tekanan Burst Terukur
2.0 MPa	2.4 MPa

4. Diameter Maksimum Guidewire

0.36 mm (0.014 inch)

5. Prinsip

Pada permukaan balon perangkat ini, terdapat tiga mata pisau yang terintegrasi sepanjang sumbu panjang balon. Ketika balon ditekan/dikembangkan, mata pisau akan menekan plak, memberikan konsentrasi tegangan pada lesi, sehingga memungkinkan terjadinya sayatan. Oleh karena itu, lesi target dapat diperlebar pada tekanan rendah.

Diameter Balon	Jumlah Mata Pisau	Tinggi Mata Pisau
2.00 - 2.50 mm	3	0.2 mm
2.75 - 3.25 mm		0.3 mm
3.50 - 4.00 mm		0.4 mm

[Tujuan Penggunaan, Indikasi]

Produk ini dimaksudkan untuk diposisikan di dalam pembuluh darah dan digunakan untuk melebarkan lesi stenosis vascular (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty: PTCA) yang sulit dilebarkan dengan POBA (Plain Old Balloon Angioplasty) konvensional.

[Tindakan Pencegahan Berkaitan dengan Tujuan Penggunaan atau Indikasi]

1. Pasien yang memenuhi kondisi berikut diindikasikan untuk menjalankan terapi dengan produk ini:

- (1) Diameter Pembuluh Target: 2.0 - 4.0 mm
- (2) Panjang Lesi: ≤ 38 mm
- (3) Tidak Ada Tortuositas Ekstrem pada Segmen Target
- (4) Derajat pembengkokan lesi: ≤ 45°
- (5) Tidak ada ulkus yang terkonfirmasi dengan angiografi
- (6) Tidak ada trombus yang terdeteksi dengan angiografi

[Kontraindikasi dan Larangan]

< Aplikasi (Pasien) >

Produk ini dikontraindikasikan pada pasien atau lesi berikut:

1. Pasien dengan spasme arteri koroner tanpa stenosis signifikan [dapat menyebabkan komplikasi seperti obstruksi koroner akut.]

< Metode Penggunaan >

1. Dilarang menerapkan penggunaan ulang dan sterilisasi ulang.
2. Menggunakan produk ini pada lesi yang telah dipasang stent. [Jika melewati strut stent atau stent yang sudah terpasang, balon yang kempis dapat tersangkut di stent.]
3. Menggunakan produk ini pada lesi distal terhadap stent yang telah terpasang. [Mata pisau dapat tersangkut di stent dan sulit dilepas.]
4. Menggunakan produk ini pada stent yang rusak atau lesi distal terhadapnya. [Mata pisau dapat tersangkut di stent dan sulit dilepas.]

[Peringatan]

< Aplikasi (Pasien) >

1. Untuk pasien dengan lesi di trunk arteri koroner kiri, ostium koroner, atau bifurkasi, ahli kardiologi dan ahli bedah jantung harus meninjau prosedur secara menyeluruh, kecuali pada kasus darurat, dan hanya jika operasi bypass koroner dinilai berisiko tinggi berdasarkan faktor latar belakang pasien dan Percutaneous Coronary Angioplasty (PTCA) dinilai berisiko rendah berdasarkan karakteristik anatomi lesi. [Dapat menimbulkan komplikasi seperti oklusi koroner akut.]

< Metode Penggunaan >

1. Gunakan secara ekstra perlahan saat menangani lesi distal dari stent. [Jika guidewire melewati strut stent dibanding lumen stent, balon yang kempis dapat terjebak di dalam stent.]

[Tindakan Pencegahan]

< Tindakan Pencegahan Dasar yang Penting >

1. Mengingat prosedur PTCA dapat menimbulkan komplikasi serius, lakukan prosedur hanya jika mekanisme kegawatdaruratan untuk coronary artery bypass grafting (CABG) telah siap.
2. Pilih ukuran balon yang sesuai dengan mempertimbangkan ukuran mata pisau agar terhindar dari pengisian balon yang melebihi diameter pembuluh darah di dekat segmen stenosis. [Pembuluh darah dapat rusak atau pecah.]
3. Saat memasukkan produk ke dalam pembuluh darah, terapi antikoagulan yang sesuai harus diberikan secara bersamaan. [Tanpa antikoagulasi, trombus dapat terbentuk, yang menyebabkan oklusi vaskular dan kejadian tidak diinginkan.]
4. Operasikan produk dengan perlahan di dalam pembuluh darah, verifikasi lokasi dan pergerakan ujungnya di bawah fluoroskopi sinar-X.
5. Jangan memutar atau membelokkan produk atau guidewire selama pengoperasian. [Kateter dapat kusut sehingga meningkatkan hambatan.]
6. Jika terasa hambatan yang kuat atau abnormalitas lain selama penggunaan produk, segera hentikan penggunaan dan periksa kemungkinan penyebab untuk mengambil tindakan yang tepat. Jangan menggunakan produk yang rusak atau mencoba memperbaikinya di tempat.
7. Lesi yang tergolong rumit seperti lesi kalsifikasi atau lesi yang berkelok-kelok mungkin tidak dapat dilewati dengan kateter ini. Dokter yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut harus menentukan apakah kateter ini sesuai berdasarkan pengalaman sebelumnya.
8. Jika ditemukan abnormalitas selama inflasi balon, segera kempiskan dan hentikan prosedur.
9. Jangan menggunakan injektor (auto-injektor) untuk melebarkan balon.
10. Produk harus selalu digunakan bersamaan dengan guidewire, dan guidewire harus dimasukkan di sepanjang lumen guidewire produk ini selama pemasangan dan pelepasan.
11. Kateter ini hanya boleh digunakan oleh dokter yang terlatih dalam terapi vaskular perkutan.
12. Jika ada bagian alat yang tertinggal di dalam tubuh, lakukan langkah-langkah untuk mengeluarkannya dari tubuh.
13. Dokter yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut harus menentukan durasi dan jumlah inflasi balon berdasarkan pengalaman sebelumnya.

14. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan pada kateter oleh pisau bedah atau gunting.
15. Jangan biarkan alat terendam dalam air panas atau bahan kimia seperti disinfektan.
16. Jangan menggunakan bahan kimia yang mengandung pelarut organik atau media kontras berminyak.

<Tindakan Pencegahan Selama Penggunaan >

1. Lepaskan pelindung dari kateter dengan perlahan, atau lepaskan bagian pelindung seperti tabung pelindung dari balon, tanpa memutarkannya. Jika terasa hambatan yang abnormal, jangan menggunakan produk tersebut dan ganti dengan yang lain. [Kerusakan pada balon atau shaft kateter dapat mencegah atau mengganggu inflasi, deflasi, atau manipulasi balon lainnya.]
2. Sebelum digunakan, keluarkan udara sepenuhnya dari balon dan lumen inflasi balon dengan menggantinya dengan media kontras yang diencerkan hingga konsentrasi yang sesuai (selanjutnya disebut sebagai media inflasi). [Jika udara tidak dikeluarkan sepenuhnya, kemungkinan inflasi balon tidak teridentifikasi pada fluoroskopi sinar-X.]
3. Gunakan media inflasi untuk mengembangkan balon. Udara atau gas lain tidak boleh digunakan untuk mengembangkan balon.
4. Sebelum balon dikembangkan, balon harus direndam dalam larutan garam steril setidaknya selama satu menit untuk mencegah penurunan kekuatan balon.
5. Jangan mengembangkan balon hingga melebihi tekanan burst terukur (RBP). [Balon dapat pecah dan serpihannya dapat tertinggal di dalam tubuh.]
6. Jangan menggerakkan kateter saat balon mengembang di dalam pembuluh darah. [Menggerakkan kateter dengan balon yang mengembang dapat menyebabkan cedera pembuluh darah, balon pecah, dan kerusakan kateter.]
7. Jangan memasukkan atau mengeluarkan produk dengan cepat. Begitu juga selama pengembangan dan pengempisan balon. [Ada risiko merusak produk, seperti balon pecah, serpihan tertinggal di dalam tubuh, atau merusak pembuluh darah.]
8. Saat memasukkan kembali produk, bilas lumen guidewire dengan larutan garam steril atau larutan garam steril yang mengandung heparin. [Trombus dapat menempel pada lumen guidewire, yang menyebabkan penurunan performa pergeseran.]
9. Perangkat medis yang digunakan dengan kateter ini harus dioperasikan sesuai dengan petunjuk penggunaan masing-masing perangkat yang diberikan oleh masing-masing produsen.
10. Jangan menggunakan produk ini jika produk atau kemasan tampak mengalami abnormalitas seperti kerusakan.
11. Gunakan produk segera setelah membuka kemasan steril. Setelah digunakan, buang produk sebagai limbah medis.

[Metode Operasi atau Petunjuk Penggunaan]

1. Persiapan
 - (1) Keluarkan kateter balon dari kemasan secara aseptik, lalu tarik keluar tabung pelindung balon dan stilet sesuai prosedur berikut. [Keluarkan produk dari kemasan dengan perlahan dan periksa apakah ada kerusakan, dll.]
 - (a) Pegang perlahan shaft kateter tepat di proksimal tabung pelindung balon dan pegang tabung pelindung balon dengan tangan lainnya.
 - (b) Dengan stilet masih terpasang di stilet kateter, perlahan geser tabung pelindung balon secara horizontal ke arah ujung dan secara bersamaan tarik tabung pelindung balon dan stilet keluar dari produk.
- (2) Keluarkan udara di dalam balon dan lumen inflasi balon sesuai prosedur berikut.
 - a) Setelah alat inflasi diisi dengan media inflasi, sambungkan alat ke hub, dan letakkan produk sehingga ujung distal menghadap ke bawah.
 - b) Setelah membuat balon dan lumen dilatasi balon bertekanan negatif selama kurang lebih 15 detik dengan alat inflasi, lepaskan tekanan negatif secara perlahan untuk mengisi balon dan lumen dilatasi balon dengan media inflasi, sehingga udara keluar.
 - c) Ulangi langkah b) untuk mengeluarkan udara sepenuhnya.
 - d) Lepaskan alat inflasi dari hub dan keluarkan udara di dalam alat inflasi.
 - e) Sambungkan kembali alat inflasi ke hub, terapkan tekanan negatif, lalu lepaskan tekanan tersebut secara perlahan setelah memastikan bahwa udara tidak kembali ke alat inflasi. [Syringe dapat digunakan sebagai pengganti alat inflasi untuk langkah a) hingga e).]
- (3) Bilas dan isi lumen guidewire dengan larutan garam steril berheparin menggunakan jarum pembilas.

2. Penyisipan ke dalam Lesi Stenosis dan Dilatasi
 - (1) Masukkan guidewire ke dalam kateter pemandu dan majukan hingga posisinya melewati lesi stenosis. [Dengan produk ini, gunakan guidewire dengan ukuran yang sesuai.]
 - (2) Masukkan produk di sepanjang guidewire dan, di bawah fluoroskopi sinar-X, majukan hingga penanda sinar-X di ujung distal produk mencapai lesi target. Saat melakukan operasi ini, pastikan balon benar-benar kempis.
 - (3) Tentukan posisi produk dan kencangkan katup hemostasis agar darah tidak bocor. Saat mengencangkan katup hemostasis, lakukan secara perlahan agar tidak terlalu kencang. [Pengencangan yang berlebihan dapat membatasi aliran media inflasi ke lumen dilatasi, dan menyebabkan waktu dilatasi dan deflasi balon yang lama.]
 - (4) Kembangkan balon hingga mencapai tekanan yang sesuai untuk lesi.
3. Pelepasan dan Penggantian
 - (1) Setelah menyelesaikan dilatasi lesi, kempiskan balon sepenuhnya dan kendurkan katup hemostasis.
 - (2) Cegah guidewire bergerak dari posisinya di arteri koroner dengan memegang guidewire dan katup hemostasis dengan satu tangan. Pegang bagian proksimal produk dengan tangan yang lain, dan tarik perlahan port guidewire hingga keluar dari guiding kateter. Saat melakukan operasi ini, pantau posisi kawat pemandu di arteri koroner di bawah fluoroskopi sinar-X.
 - (3) Tarik produk dengan perlahan dari guidewire sambil mempertahankan posisi guidewire yang melewati lokasi lesi.
 - (4) Tutup katup hemostasis.
 - (5) Jika mengganti produk dengan kateter balon lain, ikuti petunjuk penggunaan untuk persiapan dan penggunaan

[Kegagalan Perangkat dan Kejadian Tidak Diinginkan]

Penggunaan produk ini dapat menyebabkan kegagalan perangkat sebagai berikut:

1. Kegagalan Perangkat yang Parah
 - (1) Balon Pecah
 - (2) Inflasi Balon/Deflasi Malfungsi
 - (3) Shaft Kateter Pecah
 - (4) Kesulitan dalam Melepaskan Kateter
 - (5) Kerusakan/Patahnya Mata Pisau
2. Kegagalan Perangkat Lainnya
 - (1) Kebocoran Medium Inflasi
 - (2) Kesulitan dalam Memasukkan Kateter

Penggunaan produk ini dapat menyebabkan kejadian tidak diinginkan pada pasien sebagai berikut:

1. Kejadian Tidak Diinginkan Parah
 - (1) Kematian
 - (2) Infark Miokard Akut
 - (3) Oklusi Lengkap Arteri Koroner atau Cangkok Bypass
 - (4) Diseksi, Perforasi, atau Cedera Arteri Koroner
 - (5) Perdarahan Internal atau Hematoma
 - (6) Aritmia termasuk Fibrilasi Ventrikel
 - (7) Infeksi
 - (8) Kejadian yang Membutuhkan Cangkok Bypass Arteri Koroner Darurat
 - (9) Iskemia Miokard
2. Kejadian Tidak Diinginkan Lainnya
 - (1) Angina Tidak Stabil
 - (2) Spasme Arteri Koroner
 - (3) Oklusi Perifer
 - (4) Fistula Arteriovenosa
 - (5) Hipotensi/Hipertensi
 - (6) Reaksi Obat/Reaksi Alergi terhadap Media Kontras
 - (7) Restenosis setelah Dilatasi Arteri

[Penggunaan pada Wanita Hamil, Wanita dalam Masa Perinatal, Wanita Menyusui, dan Anak-anak]

Mengingat diperlukannya fluoroskopi sinar-X, produk ini hanya boleh digunakan pada wanita hamil atau wanita yang mungkin hamil jika diperkirakan manfaat terapeutiknya melebihi risikonya.

[Uji Klinis]

Efikasi dan keamanan produk dievaluasi dalam uji multisenter, label terbuka, dan tidak terkontrol yang dilakukan di Jepang untuk menargetkan lesi dimana lekukan tidak dapat diidentifikasi pada tekanan nominal POBA. Dalam uji klinis ini melibatkan total 76 pasien terindikasi PCI yang memiliki lesi stenosis koroner yang sulit

dilebarkan dengan kateter balon konvensional. (Jumlah kasus yang dianalisis: 73).

Hasil Primer :

Tingkat Keberhasilan Prosedural ※¹

Jumlah Kasus yang Dianalisis	Jumlah Kasus yang Berhasil	% [95 % CI]
73	64	87.67 % [77.88 - 94.20 %]

※¹ Tingkat Keberhasilan Prosedural: Persentase kasus dimana produk mencapai lesi target, lekukan dapat dibuat, dan stenosis residual < 50% sebelum pemasangan stent atau sebelum dilatasi pasca-DCB.

Hasil Sekunder (Cuplikan Parsial) :

Tingkat Keberhasilan Klinis ※²

Jumlah Kasus yang Dianalisis	Jumlah Kasus yang Berhasil	% [95 % CI]
73	69	94.52 % [86.56 - 98.49 %]

※² Tingkat Keberhasilan Klinis: Persentase kasus dimana produk mencapai lesi target dan berhasil dikembangkan dan dilebarkan, stenosis residual < 50% pada akhir prosedur (dievaluasi oleh QCA), dan tidak didapatkan MACE yang dilaporkan pada saat pasien dipulangkan.

Insiden MACE ※³

Jumlah Kasus yang Dianalisis	Jumlah Insiden	%
73	0	0 %

※³ MACE : Kematian Jantung, Infark Miokard, TVR

[Metode Penyimpanan dan Tanggal Kedaluwarsa]

< Kondisi Penyimpanan >

Simpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering, serta hindari terkena air dan sinar matahari langsung.

< Tanggal Kedaluwarsa >

Tanggal kedaluwarsa tertera pada kotak. [Berdasarkan sertifikasi mandiri (mengacu pada hasil uji masa simpan dari produsen.)]

Jangan menggunakan produk setelah tanggal kedaluwarsa.

[Kemasan]

1 unit / boks

[Nama dan Alamat Pabrik serta Situs Pabrik]

< Pabrik >

Nama : KANEKA CORPORATION

Alamat : 3-18, 2-Chome, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-city,
OSAKA, 530-8288 JAPAN

No. Tel. : (+81)-(0) 6-6226-5256

No. Fax : (+81)-(0) 6-6226-5143

< Situs Pabrik >

Nama : KANEKA CORPORATION OSAKA PLANT

Alamat : 5-1-1, Torikai-Nishi, Settsu-city, OSAKA, 566-0072
JAPAN